

社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會情境檢核表

操作學員：(主)_____/(副)_____ 指導員：_____

非外傷題幹(主要變化)：糖尿病患者施打胰島素後未進食，出現意識改變，血糖 42 mg/dL。

關鍵處置：血糖監測(實作)、依意識狀態選擇給糖方式、給糖後重新評估，懷疑酒精中毒先給 B1。

情境宣達：65 歲女性，有第二型糖尿病病史，今日早晨施打胰島素後，家屬發現其突然變得言語混亂、顫抖，無法正常對話，呼叫救護車。

所需器材：全套救護器材、血糖機、50% 葡萄糖 (EMTP)、糖粉或含糖食物。

操作時間：不限

項目	標準	不標準	未執行	紀錄
第一部分：現場評估及處置				
現場安全自我防護傳染病控制	☐	☐	☐	
傷病患人數與支援需求：1 名	☐	☐	☐	
意識：意識改變(躁動)，對話混亂	☐	☐	☐	
呼吸道評估：通暢	☐	☐	☐	
呼吸評估：呼吸正常	☐	☐	☐	
循環評估：橈動脈摸得到、末梢溼冷、CRT 1 秒、膚色蒼白	☐	☐	☐	
輔助檢查： BP：130/80mmHg；HR 102/Min；BT 36.5℃；Glucose 25mg/dl；SP0 ₂ 97%	☐	☐	☐	
血糖監測(實作)：解釋說明 → 備物(採血針、試紙、紙膠、酒精棉) → 選定部位消毒 → 扎針採血 → 加壓止血 → 針具丟棄銳利物桶	☐	☐	☐	
病史詢問：主訴(家屬表示患者突然變得怪怪的)／過去史(第二型糖尿病，使用胰島素)／飲食史(打完胰島素後家人去買早餐返家患者就變很奇怪)／藥物史(胰島素)／過敏史(無)	☐	☐	☐	
重點式理學檢查：神經相關檢查	☐	☐	☐	
心電圖判讀：竇性心搏過速	☐	☐	☐	
靜脈輸液(實作)：選擇葡萄糖溶液	☐	☐	☐	
考官詢問：除了輸液以外，還有何方式可以改善血糖？ 答：①糖粉抹牙齦 ②升糖素(院內) ③清醒考慮食品補充	☐	☐	☐	
病情危急度判斷：意識改變、血糖 < 60 mg/dL，低血糖急症	☐	☐	☐	
考官詢問：Whipple's Triad 三項條件？ 答：①有低血糖症狀 ②症狀出現時測得低血糖值 ③補糖後症狀緩解	☐	☐	☐	
考官詢問：低血糖與缺血性中風的鑑別重點？ 答：低血糖可表現類中風症狀(偏癱、言語不清)，任何 DM 患者意識改變應先測血糖排除低血糖，兩者處置方向截然不同。	☐	☐	☐	
第二部分：車上評估及處置				
八大生命徵象：意識(E3V4M5)；呼吸 18 下/分鐘；脈搏 102 下/分鐘； 血壓 130/80mmHg；體溫 36.5℃；瞳孔等大正常；膚色蒼白溼冷	☐	☐	☐	
依意識狀態選擇給糖方式(實作) 意識清楚、無嘔吐：口服含糖食物 / 果汁 意識不清：糖粉塗抹牙齦或舌下 EMTP：建立靜脈管路，50% 葡萄糖 25g (50ml) IVP				
給糖後 5 分鐘重新評估血糖與意識	☐	☐	☐	
考官詢問：EMTP 懷疑病患為長期酗酒合併低血糖，給糖順序為何？ 答：應先給 B1 (Thiamine) 再給糖。先給葡萄糖會消耗殘存 B1，可能誘發急性 Wernicke 腦病變。				
考官詢問：Wernicke 腦病變的三大症狀？ 答：①意識混亂(躁動、嗜睡) ②眼球運動障礙 / 眼震 ③步態失調(走路不穩)				
重新評估生命徵象並記錄	☐	☐	☐	
考官詢問：給糖後血糖回升但意識未改善，下一步？ 答：考慮其他診斷(中風、癲癇後期、感染)，立即送醫並通報。				
給糖後 5 分鐘血糖回升至 98 mg/dL，意識逐漸恢復，可正常對話				

BP(128/78mmHg)／HR 88／SPO ₂ 98%／患者表示感覺好多了		
第三部分：到院後交接		
自我介紹 Identification	☐ ／ ☐ ／ ☐	
狀況 Situation	☐ ／ ☐ ／ ☐	
背景 Background	☐ ／ ☐ ／ ☐	
評估與處置 Assessment	☐ ／ ☐ ／ ☐	
建議 Recommendation	☐ ／ ☐ ／ ☐	
教官回饋		